RG Fot barn

Endring siden forrige versjon
Revidert. Indikasjon er endret, all smerteutredning uten traume skal tas stående

Sammenligningsbilde
Kontralateral side kun på forespørsel fra henviser etter konferering med radiolog, eller på forespørsel fra radiolog.

Indikasjon	Skade, kontroll	*Front AP, Skrå innover, Side*
	Smerteutredning, deformiteter, feilstilling	*Stående Front, Skrå, Stående Side*

FRONT		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Ved spørsmål om fraktur i **tær**, inkluder hele foten.	
POSISJONERING	Pasienten liggende på ryggen, med fleksjon i kneet på aktuell side, og fotsålen flatt på bordet.	
SENTRERING	Basen av 3. metatars	
STRÅLERETNING	10˚ caudo-craniell	
BILDEKRITERIER	Foten vises uten rotasjon, med nesten lik avstand mellom 2. til 5. metatars. Inkluder hele foten, fra tærne til fotrøttene.	
KOMMENTAR		
SKRÅ INNOVER		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Ved spørsmål om fraktur i **tær**, inkluder aktuell tå og nabotå.	
POSISJONERING	Pasienten liggende på ryggen, med fleksjon i kneet på aktuell side, og foten rotert 30-40˚ medialt, med medialsiden på bordet.	
SENTRERING	Basen av 3. metatars	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Foten vises i korrekt skrå uten overprojisering mellom 3.-5. metatars, og med delvis overprojisering av basen av 1. og 2. metatars. Leddene rundt cuboideum vises åpne. Hele foten inkluderes, med tærne, bakre calcaneus og talus proksimalt.	
KOMMENTAR		

SIDE		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Ved spørsmål om fraktur i **tær**, inkluder aktuell tå og nabotå.	
POSISJONERING	Pasienten liggende på aktuell side, med omtrent 45˚ fleksjon i kneet og noe dorsalflektert fot om mulig. Foten overroteres med noen få grader for lett spredte metatarser. Ikke aktuelt bein legges bak aktuelt bein.	
SENTRERING	Like proksimalt for og i høyde med basen av 3. metatars	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Tibiotalare ledd vises åpent, og distale fibula overprojiserer bakre tibia. Metatarsene vises delvis spredt med delvis overprojisering. Hele foten inluderes fra tæren til calcaneus, samt 2-3cm av distale fibula og tibia.	
KOMMENTAR		
STÅENDE FRONT		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	**Varusfeilstilling:** Klumpfot, hulfot, calcaneovarus, equinovarus **Valgusfeilstilling:** Plattfot, hakefot, calcaneovalgus, planovalgus, «gyngemeiefot» Ved første gangs utredning på helt nyfødte, kan det være nok med et «slapt» front og sidebilde. Det dreier seg da om å utelukke skjelettanomalier, for eksempel manglede knokler, sammenvoksinger osv.	
POSISJONERING	Pasienten stående på detektor med god vekt på aktuell fot. Der barnet ikke kan stå eller ikke kan samarbeide presses foten ned (f.eks med et CD-cover) for å illudere belastning.	
SENTRERING	Basen av 3. metatars	
STRÅLERETNING	10˚ caudo-craniell	
BILDEKRITERIER	Foten vises uten rotasjon, med nesten lik avstand mellom 2. til 5. metatars. Inkluder hele foten, fra tærne til fotrøttene. Merk bildet med «stående».	
KOMMENTAR		
STÅENDE SIDE		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	**Varusfeilstilling:** Klumpfot, hulfot, calcaneovarus, equinovarus **Valgusfeilstilling:** Plattfot, hakefot, calcaneovalgus, planovalgus, «gyngemeiefot» Ved første gangs utredning på helt nyfødte, kan det være nok med et «slapt» front og sidebilde. Det dreier seg da om å utelukke skjelettanomalier, for eksempel manglede knokler, sammenvoksinger osv.	
POSISJONERING	Pasienten stående med vekt på aktuell fot med detektoren plassert vertikalt enten medialt eller lateralt. Still inn sidebildet etter ankelleddet/bakre fot. 90° i ankelleddet. Der barnet ikke kan stå eller ikke kan samarbeide presses foten ned (f.eks med et CD-cover) for å illudere belastning.	

SENTRERING	Like proksimalt for og i høyde med basen av 3. metatars
STRÅLERETNING	0˚ med horisontal strålegang vinkelrett på detektor. Kan tas både mediolateralt og lateromedialt.
BILDEKRITERIER	Tibiotalare ledd vises åpent, og distale fibula overprojiserer bakre tibia. Metatarsene er nærmest helt overprojisert av hverandre, med unntak av deler av 5. metatars. Inkluder hele foten med 2-3cm av distale fibula og tibia. Merk bildet med «stående».
KOMMENTAR	

Referanser

Vedlegg

Slutt på Prosedyre